MÉTHODE OFFICIELLE DU MAJOR DES EDN 2025

LE CARNET D'ERREURS EDN

Le Système Actif pour Ne Plus Jamais Reproduire la Même Erreur en QCM & ECOS

28 Spécialités Médicales • Modèle Prêt à l'Emploi

« Les erreurs sont nos meilleurs professeurs… à condition de les relire. »
— Hédi, Major des EDN 2025

1. Le Principe Fondamental du Carnet d'Erreurs

90% des étudiants commettent la même faute stratégique : après un concours blanc ou une session de QCMs, ils regardent leur pourcentage, lisent superficiellement la correction, puis passent à autre chose. Deux semaines plus tard, retombant sur le même piège clinique, ils reproduisent exactement la même faute.

Le carnet d'erreurs repose sur un principe actif radical : **chaque erreur commise doit être immédiatement formulée en UNE SEULE PHRASE percutante** et classée dans sa spécialité. Vous ne relisez plus vos 2 000 pages de cours la veille du concours : vous relisez les 150 pièges qui vous ont personnellement fait trébucher.

2. Exemples de Pièges Déjoués par Spécialité

Spécialité : Cardiologie & Urgences

Piège R2C / Question Clé	Réflexe Diagnostique / Formule Majore
Arrêt cardiaque en asystolie / RACS	L'amiodarone et la lidocaïne sont STRICTEMENT contre-indiquées en asystolie ; réservées uniquement à la FV/TV sans pouls après le 3e choc.
Dissection aortique type A	L'anticoagulation (héparine) est MORTELLE et formellement proscrite. L'angioscanner aortique est l'examen de référence en urgence.
OAP cardiogénique sous diurétiques	Ne pas prescrire de dérivés nitrés si PAS < 100 mmHg ou en cas d'infarctus du ventricule droit.

Spécialité : Neurologie

Piège R2C / Question Clé	Réflexe Diagnostique / Formule Majore
Inhibiteur DPP-4 sans adaptation rénale	La linagliptine est la SEULE gliptine ne nécessitant aucune réduction de posologie en cas d'insuffisance rénale terminale.
Syndrome de Claude Bernard-Horner	Myosis + Ptosis + Énophtalmie unilatérale. Suspecter d'urgence une dissection de l'artère carotide interne cervicale.
Ataxie cérébelleuse + Confusion chez l'éthylique	Injection immédiate de Vitamine B1 intraveineuse AVANT tout apport glucosé pour prévenir l'encéphalopathie de Wernicke.

Spécialité : Infectiologie

Piège R2C / Question Clé	Réflexe Diagnostique / Formule Majore
Infection à coqueluche (Bordetella)	L'hyperlymphocytose > 50 000/mm³ stimulée par la toxine pertussique est un critère de gravité majeur imposant le transfert immédiat en réanimation.
Urétrite gonococcique	Ceftriaxone 1g IM dose unique. Aucune autre céphalosporine de 3e génération per os n'est validée en 1ère intention.
Gale humaine (Sarcoptes scabiei)	Traitement concomitant obligatoire de TOUT l'entourage même asymptomatique + décontamination du linge à 60°C.

Spécialité : LCA (Lecture Critique d'Articles)

Piège R2C / Question Clé	Réflexe Diagnostique / Formule Majore
Courbe ROC et puissance diagnostique	L'adjonction d'un nouveau biomarqueur n'est cliniquement valide que si l'aire sous la courbe (AUC) augmente de manière statistiquement significative (test de DeLong).
Étude de non-infériorité	La borne delta doit être fixée a priori et l'analyse doit impérativement être concordante en Per-Protocole ET en Intention de Traiter (ITT).